

Grile varianta E

1 ACD

1. Mediile transparente ale ochiului sunt reprezentate de:
- a.) Umoarea apoasa
 - b.) Retina
 - c.) Corneea
 - d.) Cristalinul
 - e.) Sclera

2 BCE

2. Urmatoarele afirmatii referitoare la miopie sunt adevarate
- a.) Este o tulburare de refractie in care razele paralele, venite de la infinit, se focalizeaza in spatele retinei
 - b.) Este o tulburare de refractie in care razele paralele, venite de la infinit, se focalizeaza in fata retinei
 - c.) Unul dintre factorii majori ce determina cresterea axului ocular este activitatea indelungata la aproape
 - d.) Se corecteaza cu lentile cilindrice notate cu plus
 - e.) La majoritatea pacientilor, procesul de crestere al dimensiunilor globului ocular se opreste inaintea varstei de 30 de ani

3 ABDE

3. Herpesul zoster oftalmic se poate asocia cu:
- a.) Istoric de imunodeficienta
 - b.) Debut clinic cu formatiuni maculo-papulare eritematoase la nivelul tegumentului deservit de nervul oftalmic de aceeasi parte
 - c.) Absenta durerii
 - d.) Durere cu caracter de arsura cutanata, persistenta
 - e.) Afectare oculara in formele severe

4BCDE

4. Semnele oftalmice in dacrioadenita acuta constau in:
- a.) Edematizarea si tumefierea pleoapei inferioare in treimea interna
 - b.) Chemozis si hiperemie conjunctivala
 - c.) Edematizarea si tumefierea pleoapei superioare luand forma de "S" culcat
 - d.) Secretii muco-purulente
 - e.) Cresterea in volum a glandei lacrimale principale

5 A

5. *Trichiiazisul este:
- a.) Maldirectionarea cililor palpebrali
 - b.) Lipsa tonusului pleoapei superioare
 - c.) Retractia pleoapei superioare
 - d.) Sudarea suprafetelor conjunctivale tarsala si bulbara
 - e.) Absenta cililor palpebrali

6 ACD

6. In functie de profunzime, arsurile corneene fizice se pot clasifica in:
- a.) Arsura de gradul I cu fine dezepitelizari corneene
 - b.) Arsura de gradul I cu flicte la nivelul pleoapelor si diminuarea transparentei corneene
 - c.) Arsura de gradul II cu dezepitelizari conjunctivale, corneene si diminuarea transparentei corneene

Grile varianta E

- d.) Arsura de gradul III cu o corneea lipsita de transparenta
- e.) Arsura de gradul I cu multiple dezepitelizari corneene asociate cu edem cornean marcat

7. Arsurile corneene cu baze prezinta urmatoarele particularitati:
- a.) Necroza de coagulare fara penetrarea substantei in profunzimea tesuturilor
 - b.) Necroza de lichefiere soldata cu ruperea membranelor celulare
 - c.) Penetrare rapida a tesuturilor
 - d.) Patrunderea in profunzime a substantei
 - e.) Un prognostic mai favorabil comparativ cu arsurile chimice cu acizi

7BCD

8. Printre complicatiile postoperatorii imediate ale chirurgiei cataractei regasim:
- a.) Edemul cornean mecanic
 - b.) Hipertensiunea intraoculara pasagera
 - c.) Hifema postoperatorie
 - d.) Opacifierea capsulei posterioare
 - e.) Astigmatismul postoperator precoce prin plasarea firelor de sutura

8 ABCE

9. Selectati afirmatiile false:
- a.) Eliminarea umorului apos se face pe 6 cai
 - b.) Glaucomul primar cu unghi deschis impune tratament chirurgical de prima intentie
 - c.) Glaucomul cu unghi inchis reprezinta o urgenta oftalmologica
 - d.) Glaucomul cu unghi inchis face parte din sindromul de ochi rosu
 - e.) **Glaucomul** neovascular este de cele mai multe ori consecinta unor afectiuni ischemice retiniene de tipul obliterarii de vena centrala a retinei

9 ABD
dar nu sunt
sigur

10. Modificarile papilare din boala glaucomatoasa constau in:
- a.) Largirea in volum a excavatiei optice in raport cu dimensiunea totala a corpului nervului optic
 - b.) Hemoragii la nivelul discului optic
 - c.) Edem macular
 - d.) Exudate dure si de tip cotton-wool in periferia retinei
 - e.) Iluzia optica de deplasare nazala a vaselor de la nivelul papilei nervului optic

10 ABE

11. Glaucomul de 100 de zile prezinta urmatoarele particularitati:
- a.) Valori foarte crescute ale presiunii intraoculare
 - b.) Absenta durerii
 - c.) Edem cornean
 - d.) Dureri oculare intense
 - e.) Rubeoza iriana

12 ACD

12. Tulburarile de secretie lacrimala constau in:
- a.) Scaderea cantitatii de lacrimi
 - b.) Cresterea cantitatii de lacrimi
 - c.) Lacrimare prin hipersecretie
 - d.) Lacrimare prin hipoexcretie
 - e.) Lacrimare prin hiperexcretie

12 ABCD

Grile varianta E

13. Simptomatologia in cadrul dezlipirii de retina regmatogena este reprezentata de:

13 ABCE

- a.) Miodezopsii sau puncte negre pe un fundal alb
- b.) Fosfene sau senzatia de flash-uri
- c.) Scaderea acuitatii vizuale
- d.) Durere oculara intense
- e.) Prezenta unei umbre in campul visual

14. *Cea mai frecventa cauza a ocluziei de artera centrala a retinei este reprezentata de:

14 B

- a.) Arterita cu celule gigante
- b.) Tromboza
- c.) Policitemia
- d.) Sindromul antifosfolipidic
- e.) Periarterita

15. Examenul fundului de ochi in ocluzia de artera centrala a retinei scoate in evidenta urmatoarele modificari:

15 ABC

- a.) Edemul retinian difuz
- b.) Cireasa maculara sau cherry red spot
- c.) Ingustarea si subtierea arterelor retiniene
- d.) Marirea raportului cupa-disc de la nivelul papilei nervului optic
- e.) Exudatele dure maculare

16. Factorii predispozanti frecvent intalniti in ocluzia de vena centrala a retinei sunt:

16 ABC

- a.) Varsta inaintata peste 65 de ani
- b.) Hipertensiunea arteriala
- c.) Diabetul zaharat
- d.) Sindromul Behcet
- e.) Sarcoidoza

17. Modificarile specifice examenului fundului de ochi in retinopatia diabetica neoproliferativa sunt:

17 ABCE

- a.) Microanevrisme
- b.) Hemoragii retiniene sub forma de pete punctiforme si hemoragii in flacara
- c.) Exudate dure lipidice
- d.) Neovascularizatie iriana
- e.) Exudate moi ischemice

18. Degenerescenta maculara legata de varsta forma uscata prezinta urmatoarele aspecte patologice:

18 ABC

- a.) Disparitia progresiva a epiteliului pigmentar retinian
- b.) Aparitia de zone atrofile in zona maculara
- c.) Scaderea acuitatii vizuale
- d.) Dezvoltarea de membrane neovasculare
- e.) Hemoragii intraretiniene cauzate de neovase

Grile varianta E

19 ACE

19. Urmatoarele afirmatii legate de celulita orbitara sunt adevarate:

- a.) Reprezinta inflamatie difuza a tesutului celulo-adipos al orbitei
- b.) Este o inflamatie localizata a tesutului cutanat
- c.) Pacientul prezinta durere orbitara si cefalee
- d.) Obiectiv se evidentiaza doar o congestie conjunctivala minima
- e.) Exoftalmia axiala unilaterala este nereductibila cu imobilitatea globului ocular

20 ACDE

20. Simptomatologia obiectiva a glaucomului cu unghi inchis este caracterizata de:

- a.) Presiune intraoculara foarte crescuta cu valori intre 45 si 70 mmHg
- b.) Presiune intraoculara normala cu valori sub 20 mmhg
- c.) Congestie conjunctivala mixta perikeratica
- d.) Pupila in semimidriaza, areflexiva
- e.) Edem cornean

21 A

21. *Tunica interna a globului ocular este formata din:

- a.) Retina
- b.) Iris
- c.) Corneea
- d.) Sclera
- e.) Vitros

22 BE

22. Urmatoarele afirmatii legate de xantelasmale palpebrale sunt adevarate:

- a.) Se impune de urgenta cura chirurgicala
- b.) Sunt acumulari anormale de colesterol si alti constitienti lipidici
- c.) Sunt intotdeauna unilaterale
- d.) Nu recidiveaza niciodata postchirurgical
- e.) Pacientul trebuie informat asupra posibilitatii recidivarii

ABD

23. Plaga corneeană penetrantă prezintă următoarele caracteristici:

- a.) Glob ocular hipoton
- b.) Camera anterioară de profunzime redusă sau chiar absentă
- c.) Glob ocular hipertonic
- d.) Posibilitatea prolăbarii în exterior a irisului prin plagă
- e.) Camera anterioară de profunzime mărită

24 ACDE

24. Urmatoarele afirmatii sunt adevarate:

- a.) Retina prezinta 10 straturi histologice
- b.) Corneea reprezinta tunica interna a globului ocular
- c.) Tunica externa este reprezentata de corneea
- d.) Retina maculara reprezinta zona centrala a retinei
- e.) Tunica medie este reprezentata de uvee

25 A

25. *Caracteristicile intalnite in stadiul tonometric al glaucomului primar cu unghi deschis:

- a.) O crestere moderata a presiunii intraoculare intre 21 si 30 mmHg
- b.) Presiune intraoculara ce depaseste valoarea de 60 mmHg
- c.) Atrofie optica totala

Grile varianta E

- d.) Modificari degenerative la nivelul maculei
- e.) Ingustare concentrica marcata a campului visual

26 ABE

26. Masurarea acuitatii vizuale presupune:
- a.) Sunt utilizate teste speciale numite optotipuri
 - b.) Acuitatea vizuala se masoara de la distanta de 5 m
 - c.) O acuitate vizuala egala cu pmm semnifica percepe lumina
 - d.) Acuitatea vizuala se masoara de la distanta de 8m
 - e.) Daca pacientul nu vede primul rand de la distanta de 5 m atunci este adus la 1m de optotip

27 B

27. *Examenul unghiului camerular cu ajutorul unei lentile de contact poarta numele de:
- a.) Tonometrie
 - b.) Gonioscopie
 - c.) Campimetrie
 - d.) Exoftalmometrie
 - e.) Ecografie

28 DE
chatgpt

28. Caracteristicile tonometriei prin indentatie sunt:
- a.) Folosirea tonometrului Goldmann
 - b.) Utilizarea fluoresceinei
 - c.) Pozitionarea pacientului in sezut
 - d.) Folosirea tonometrului Schiotz
 - e.) Administrarea de anestezic topic la nivel ocular

29 ACDE

29. Exoftalmometria prezinta urmatoarele caracteristici:
- a.) Valorile normale sunt intre 12 si 15 mm
 - b.) O valoare de peste 2 mm defineste o exoftalmie foarte mare
 - c.) Se foloseste exoftalmometrul Hertel
 - d.) In exoftalmia unilaterala, diferenta de proeminenta a celor 2 ochi indica gradul exoftalmiei
 - e.) Masoara protuzia globului ocular

30
ACD

30. Caracteristicile tonometriei prin aplanatie Goldmann:
- a.) Utilizarea unui biomicroscope
 - b.) Pacientul sa fie intins pe un pat cu privirea orientata spre picioare
 - c.) Utilizarea fluoresceinei
 - d.) Aspectul de S culcat al mirelor
 - e.) Lipsa de contact intre tonometru si suprafata oculara

31 AB

31. Caracteristicile campimetriei:
- a.) Evalueaza campul vizual al pacientului
 - b.) Este o examinare necesara pacientilor glaucomatosi
 - c.) Consta in masurarea tensiunii intraoculare
 - d.) Permite vizualizarea deschiderii unghiului camerular
 - e.) Oferă detalii despre gradul exoftalmiei pacientului

Grile varianta E

32. *Un viciu de refractie de +1,50 dioptrii sferice este reprezentativ pentru:
- 32 B**
- a.) Miopia
 - b.) Hipermetropia
 - c.) Astigmatismul mixt
 - d.) Astigmatismul hipermetropic simplu
 - e.) Astigmatismul hipermetropic compus
33. *Care dintre urmatoarele este o ametropie sferica:
- A**
- a.) Miopia
 - b.) Astigmatismul hipermetropic simplu
 - c.) Astigmatismul hipermetropic compus
 - d.) Astigmatismul miopic simplu
 - e.) Astigmatismul mixt
34. Hemianopsia bitemporala poate fi numita si:
- 34 AD**
- a.) O hemianopsia heteronima
 - b.) O hemianopsia omonima
 - c.) Amputarea campului vizual in sectorul superior al ambilor ochi
 - d.) Amputarea campului vizual in sectorul temporal al ambilor ochi
 - e.) Amputarea campului vizual temporal al ochiului drept
35. *Acuitatea vizuala notata N.D. semnifica:
- 35 B**
- a.) O vedere de 0,5
 - b.) Numara degetele
 - c.) o vedere egala cu 0.7
 - d.) percepe miscarile mainii
 - e.) o vedere egala cu 0.9
36. *Viciu de refractie de -6,25 dioptrii sferice reprezinta:
- A**
- a.) Miopia
 - b.) Hipermetropia
 - c.) Astigmatismul mixt
 - d.) Astigmatismul miopic simplu
 - e.) Astigmatismul miopic compus
37. Urmatoarele afirmatii despre ultrasonografia oculara si orbitala sunt adevarate:
- 37 AE
suna
logic**
- a.) Oferă detalii despre lungimea axiala a globului ocular
 - b.) Masoara puterea de refractie a cristalinului- biometria ultrasonica
 - c.) Nu ofera detalii despre prezenta unei dezlipiri de retina
 - d.) Nu este indicata in diagnosticul tumorilor intraoculare
 - e.) Este utila in globii oculari cu medii opace
38. *Detaliile oferite de exoftalmometrie sunt:
- a.) Posibilele fracturi de orbita
 - b.) Protuzia globului ocular

Grile varianta E

- c.) Continutul globului ocular
- d.) Profunzimea camerei anterioare
- e.) Puterea de refractie a cristalinului

39 ABC
era la
practic

39. Care din urmatoarele afirmatii despre testul Schirmer 1 sunt adevarate:
- a.) Masoara secretia lacrimala totala
 - b.) Se folosesc doua benzi de hartie de filtru late de 5mm si lungi de 35 mm
 - c.) Hiposecretia lacrimala este definita prin umectarea unei portiuni mai mici de 15 cm
 - d.) Umectarea normala a benzii este intre 1 si 3 cm
 - e.) Inferior 10-20 grade

40
BCD

40. Care sunt limitele medii ale CV monocular:
- a.) Temporal 20-30 grade
 - b.) Temporal 80-90 grade
 - c.) Nazal 50-60 grade
 - d.) Inferior 60-70 grade
 - e.) Inferior 10-20 grade

41 AB

41. Care sunt factorii care depind de pacientul examinat si influenteaza calitatea campului visual:
- a.) Refractia
 - b.) Diametrul pupilar
 - c.) Suprafata testului
 - d.) Calitatea luminii
 - e.) Viteza de prezentare a testului

42 A

42. *Tonometria este:
- a.) Masurarea presiunii intraoculare
 - b.) Evaluarea campului visual
 - c.) Masurarea protuziei globului ocular
 - d.) Evaluarea calitatii filmului lacrimal
 - e.) Examinarea fundului de ochi

43 CDE

43. Care dintre urmatoarele afirmatii despre tonometrul non-contact sunt adevarate:
- a.) Impune anestezierea corneei
 - b.) Riscul de infectare al pacientului este inalt
 - c.) Nu necesita anestezierea corneei
 - d.) Corneea este aplatizata de un jet de aer
 - e.) Nu exista pericol de infectare al pacientului

44
ABCD

44. Examinarea biomicroscopica a irisului urmareste:
- a.) Modificari de culoare iriana
 - b.) Modificari de pozitie iriana
 - c.) Modificari de relief irian
 - d.) Motilitatea irisului

Grile varianta E

e.) Reflexul pupilei

45 AC

45. Care sunt cauzele congenitale ale hipofunctiei glandei lacrimale:

- a.) Aplazia glandei lacrimale
- b.) Sarcoidoza
- c.) Aplazia trigeminala
- d.) Parotidita epidemica
- e.) Arsura chimica

46ACD

46. Simptomatologia specifica scaderii secretiei lacrimale:

- a.) Senzatia neplacuta de arsura
- b.) Diplopie
- c.) Aparitia unei secretii lipicioase
- d.) Senzatia de usturime
- e.) Ingustarea campului visual

47
AC

47. Care sunt variatiile patologice ale sensibilitatii corneene:

- a.) Hipoestezia corneana
- b.) Saderea transparente corneene
- c.) Hiperestezia corneana
- d.) Absenta luciului cornean
- e.) Megalocorneea

48 C

48. *Urmatoarele afirmatii despre biomicroscopie sunt false:

- a.) Permite examinarea focala a polului anterior
- b.) Oferă detalii despre grosimea corneei
- c.) Utilizeaza doar lumina alba
- d.) Este folosita in examinarea fundului de ochi
- e.) Permite evaluarea profunzimii camerei anterioare

49 ABCE

49. Care sunt factorii obiectivi care influenteaza efectuarea campului visual:

- a.) Suprafata testului
- b.) Intensitatea luminoasa a testului
- c.) Viteza de prezentare a testului
- d.) Cooperarea pacientului
- e.) Durata de prezentare a testului

50 AB
carte \
practic

50. Care dintre urmatoarele afirmatii legate de eritropsie sunt adevarate:

- a.) Reprezinta vederea colorata in rosu a unei suprafete albe
- b.) Este intalnita in hemoragia in vitros
- c.) Pacientul vede suprafata alba ca fiind colorata in albastru
- d.) Se asociaza cu intoxicatia cu ciuperci
- e.) Se regaseste in intoxicatia cu xantonina